

INDICADO POR: Interjet / Dr. Caragosa.
() ACOMPANHAMENTO ☒ CONSULTA
NS

JOSE AUGUSTO FERREIRA COUTO

IDADE: 64 PESO: 73 ALTURA: 173 PROFISSÃO: consultor negócios (Sbraz)

SINTOMAS: sonolência / cansaço / AEC / arritmia

QUEIXAS: Falta de ar (eufargo) - despertares

MEDICAMENTOS: Losartana / Doxaroxina / Metoprolol

MÉDICO: Dr. Alexandre Ricardo

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhada (4x) 40'

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: S 19h

HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILHO: () S () N ☒ S DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE baixo

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () N ☒ X NA SEMANA () N eventualmente

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 37.9 SPO2: 85%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Desvio Septo. Dorme rápido
sinusite Despertares 18,2/ev.
(23 - 5m)

CIRURGIAS: () N NASAL () N AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: —

COMORBIDADE: () S RESPIRATÓRIA () N ENDÓCRINA () S CARDÍACA HAS / Arritmia

() N ORTOPÉDICA () S NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

23/06 Avaliação - já utiliza CPAP de forma expirada

25 Localização de CPAP p/ titulação
P= 4.5 CPAP fixo nariz. nasal utilizando facial.

30/06 P= 7.0 predioma 9.0 perc.

25 Coloca este parâmetro no CPAP Sq (s/ umidif) 9.0

Nome: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA COUTO
Data de Nascimento: 17-1-1961
IMC: 24,39
Sexo: Masculino
Data do exame: 04-10-2021

Peso: 73 kg
Altura: 1,73 m
Médico: DR. RICARDO CAVALCANTE
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-10-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO₂) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 481,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 9,0 e 74,0 minutos. O tempo total de sono foi de 310,5, eficiência de 64,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,2%; estágio N2: 63,3%; estágio N3: 12,6%; sono REM: 20,0%. O índice de despertares foi de 18,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 37,9/hora, sendo elas 8 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 175 hipopnéias. A SpO₂ média foi de 94% e mínima de 85%, permanecendo 2,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 97 bpm e NREM de 55 - 99 bpm.

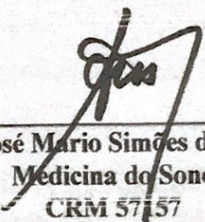
CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (08), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 37,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO₂=85%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco no traçado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157